Bitácora Médica de Guardia

Periodo: 13/11/2026 AL 14/11/2026 | Hospitalización, Periféricos y Emergencia

AUTHOR
MD. ZAMBRANO PG MEDICINA INTERNA, MD. BUENDIA MRA

PUBLISHED
November 13, 2026

Resumen Ejecutivo de la Guardia

> ⓘ **Censo Operativo:** Total: **53** pacientes | Hospitalizados: **17** | Periféricos: **12** | Emergencia/Obs: **24** | Nuevos ingresos de guardia: **0**

Accesos Rápidos: Censo drive

Checklist de la Visita Nocturna (Pendientes Críticos)

> [!IMPORTANT] Esta lista compila todas las tareas con horario crítico, exámenes STAT, controles de madrugada y cambios farmacológicos programados para el equipo de guardia.

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
URGENTE	**10A**	MOSQUERA SALVADOR PATRICIA ALEXANDRA C (HC 1334681)	UROTAC SIMPLE	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**10A**	MOSQUERA SALVADOR PATRICIA ALEXANDRA C (HC 1334681)	L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROLITOS CALCIO IONICO (CONTEO MANUAL DE	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	**10A**	MOSQUERA SALVADOR PATRICIA ALEXANDRA C (HC 1334681)	EKG STAT	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
URGENTE	10B	REYES SANCHEZ INES MAGDALENA C (HC 8140)	E: RMN DE ENCEFALO AGENDAR HOY EN LA MAÑANA	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
STAT	10B	REYES SANCHEZ INES MAGDALENA C (HC 8140)	EKG CADA DIA (STAT)	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	10B	REYES SANCHEZ INES MAGDALENA C (HC 8140)	L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROITOS CALCIO IONICO MAGNESIO DIMERO D	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	10C	CHANGO GADVAY MARIA ADELAIDA (HC 1996362)	E: LABS: HBS, HBC, HEPATITIS C, VIH, QUANTIFERON PENDIENTE	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	10C	CHANGO GADVAY MARIA ADELAIDA (HC 1996362)	L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROLITOS DIMERO D MAGNESIO CALCIO IONICO	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	10C	CHANGO GADVAY MARIA ADELAIDA (HC 1996362)	IC FISIROTERAPIA MOTORA	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	10D	OÑA TELLO JOSELYN CAROLINA (HC 1719421)	PENDIENTE INFORME ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS DE CABEZ Y TORAX POSTERIOR	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	10D	OÑA TELLO JOSELYN	PENDIENTE TOMOGRAFIA SIMPLE DE	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
		CAROLINA (HC 1719421)	CABEZA, TORAX Y PELVIS		
URGENTE	**10D**	OÑA TELLO JOSELYN CAROLINA (HC 1719421)	VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO POR EL COMITÉ DE BIOÉTICA	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**11A**	YELA DÍAS NELSON ARNULFO (HC 641333)	E: PD INFORME DE TAC DE TORAX	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	**11A**	YELA DÍAS NELSON ARNULFO (HC 641333)	GSA STAT	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**11A**	YELA DÍAS NELSON ARNULFO (HC 641333)	L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROLITOS PCR PERFIL LIPIDICO HBA1C TSH	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**11A**	YELA DÍAS NELSON ARNULFO (HC 641333)	LABORATORIOS (17H00): DESTACA MEJORIA DE AZOADOS POST-DIÁLISIS (UREA 67.8, CR	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**12A**	CALDERON ALMEIDA SIMON BOLIVAR (HC 2007245)	E: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO JUEVES 12H00	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**12A**	CALDERON ALMEIDA SIMON BOLIVAR (HC 2007245)	L: PENDIENTE LAB CENTRAL	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**12A**	CALDERON ALMEIDA SIMON	SE REALIZA IC A ODONTOLOGIA	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
		BOLIVAR (HC 2007245)	PENDIENTE VALORACION		
STAT	3B	BORJA PAUCARIMA VICTORIA AVELINA 69 AÑOS (HC N/D)	C: IC A CLINICA DEL DOLOR YA REALIZADA POR DOLOR CRÓNICO DEBIDO A LESIONES CERVICALES	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	6A	RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL (HC 2013397)	PENDIENTE EXÁMENES GENERADOS EL 12/11/2026	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	6A	RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL (HC 2013397)	PENDIENTE TAC SIMPLE DE TÓRAX	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	6A	RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL (HC 2013397)	VALORACIÓN POR NEUMOLOGÍA	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
CONTROL	6A	RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL (HC 2013397)	PROXIMO CONTROL: 06/11/2026	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	6C	ALMEIDA JARAMILLO JUAN CARLOS C (HC 2086486)	TAC SIMPLE DE CRÁNEO PENDIENTE	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	6C	ALMEIDA JARAMILLO JUAN CARLOS	PENDIENTE REALIZACIÓN	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
		C (HC 2086486)			
URGENTE	6C	ALMEIDA JARAMILLO JUAN CARLOS C (HC 2086486)	PAAF DE GANGLIO CERVICAL (IMAGEN) PENDIENTE REALIZACIÓN	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	6D	FARINANGO ANDRADE JUAN MANUEL (HC N/D)	E:PENDIENTE RX DE TÓRAX ANTEROPOSTERIOR Y LATERAL	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	8	NICOLALDE CENTENO CESAR ENRIQUE (HC 554153)	PD REALIZACION ECO DOPPLER PORTAL	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
STAT	9A	ROSAS CORREA MARIA ESTHER C (HC 124595)	RADIOGRAFIA DE TORAX YA	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	9B	CARRERA AGUIRRE MARTHA GRACIELA C (HC 2045964)	L. PENDIENTE RESULTADOS DE ELECTROLITOS 12/11/2026	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	9D	GUERRERO PAULA DOLORES NARCIZA (HC 677814)	PD RESULTADOS DE TAC DE TORAX	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
CONTROL	ABREVIADOS 2	FREIRE LOPEZ MARCO FERNANDO (HC 987792)	L: HBA1C Y TSH MAÑANA	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
CONTROL	ABREVIADOS 3	GUEVARA JARAMILLO MARTHA YOLANDA C (HC 140019)	EXÁMENES DE CONTROL EL DIA LUNES	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	ABREVIADO 3B	LIDIOMA MINANGO KATHERINE ELIZABETH C (HC 1786985)	PD TAC DE TORAX	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	ABREVIADO 3B	LIDIOMA MINANGO KATHERINE ELIZABETH C (HC 1786985)	ECOCARDIOGRAMA PD TURNO	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
CONTROL	ABRE 1	ORTIZ MARIA ANGELA C (HC 520780)	LUNES EXAMENES DE LABORATORIO DE CONTROL	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
CONTROL	ABRV 2	CALVA SALAS GRETA (HC 1158688)	EXAMENES DE CONTROL PARA EL DIA LUNES	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	ABRV 3A	VARGAS BAUTISTA ANA PIEDAD C (HC 1234469)	HEMOCULTIVOS X 2 HOY	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	ABRV 3A	VARGAS BAUTISTA ANA PIEDAD C (HC 1234469)	VALORACION POR HEMAOTLOGIA E INFECTOLOGIA	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	ABRV 3A	VARGAS BAUTISTA ANA PIEDAD C (HC 1234469)	TAC SIMPLE DE ALBOMEN Y PELVIS PENDIENTE	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
URGENTE	ABRV 3A	VARGAS BAUTISTA ANA PIEDAD C (HC 1234469)	PET SCAN HOY	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	ABRV 3B	GAVIN YERBABUENA MARIA CRISTINA C (HC 1597943)	PD INFORME DE TAC DE ABDOMEN	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
CONTROL	ABRV 3B	GAVIN YERBABUENA MARIA CRISTINA C (HC 1597943)	LUNES EXAMENES DE CONTROL	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	ABRV 3B	GAVIN YERBABUENA MARIA CRISTINA C (HC 1597943)	CLOSTRIDIIUM TOXINA A Y B HOY	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
CONTROL	ABR 3A	DUQUE VERGARA MARIA ESTHER (HC 109881)	CONTROL DE ELECTROLITOS A LAS 4 HORAS, LUEGO DE HABER RECIBIDO EL PRIMER CICLO DE NEBULIZACION	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	ABV1	VASCONEZ RUALES CARLOS AUGUSTO (HC 297135)	BODY TAC SIMPLE	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
STAT	ABV1	VASCONEZ RUALES CARLOS AUGUSTO (HC 297135)	ELECTROCARDIOGRAMA STAT	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
URGENTE	ABV1	VASCONEZ RUALES CARLOS AUGUSTO (HC 297135)	ECOGRAFIA DE TIROIDES AGENDADA, PENDIENTE REALIZAR	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
CONTROL	ABV1	VASCONEZ RUALES CARLOS AUGUSTO (HC 297135)	L: -MAÑANA BH PCT , PCR , GLUCOSA, ELECTROLTIOS	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
STAT	ABV2	MALDONADO CAYAMBE DARWIN BENITO C (HC 2090778)	ECOGRAFIA VESCICO PROSTATICA	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
CONTROL	ABV2	MALDONADO CAYAMBE DARWIN BENITO C (HC 2090778)	MAÑANA AM: PSA TOTAL Y LIBRE, CEA, AFP	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
STAT	ABV 2	FLORES NARANJO MENTOR GUILLERMO (HC 2062807)	EKG STAT	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	ABV 2	FLORES NARANJO MENTOR GUILLERMO (HC 2062807)	UROTAC SIMPLE	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
CONTROL	ABV 2	FLORES NARANJO MENTOR GUILLERMO (HC 2062807)	MAÑANA BIOMETRIA HEMATICA, ELECTROLITOS, UREA, CREATININA	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
CONTROL	ABV 3 A	CAMACHO PINEDA RICAURTE DE JESUS C (HC 2087368)	LUNES EXAMENES DE LABORATORIO DE CONTROL	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	ABV 3 B	LOPEZ FIGUEROA OLGA MARLENE C (HC 1556289)	PENDIENTE ECO DE HIGADO A DESCARTAR CIRROSIS	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	AB 1_2	GALLEGOS ACOSTA FERNANDA BETSABE C (HC 1727494)	ECOGRAFÍA DE ABDOMEN (HEPATITIS AUTOINMUNE)	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	AB 2	ALMAGRO PICO JORGE WASHINGTON 74 AÑOS (HC N/D)	HEMOCULTIVOS X2 DEL 04/11/2026 PENDIENTE RESULTADO	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	CARDIO 3C	HIDALGO NIETO CARLOS GONZALO 72 AÑOS (HC 963279)	TAC SIMPLE DE ENCÉFALO, CUELLO, TÓRAX, ABDOMEN Y PELVIS. (HACER INFORMAR)	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	CARDIO 3C	HIDALGO NIETO CARLOS GONZALO 72 AÑOS (HC 963279)	EDA Y COLONOSCOPIA REALIZADA: REPETIR COLONOSCOPIA PENDIENTE TURNO	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente
URGENTE	CARDIO 3C	HIDALGO NIETO CARLOS GONZALO 72	VALORACIÓN POR CIRUGÍA VASCULAR (INSUFICIENCIA ARTERIAL CRONICA): ALTA	NOCTURNA_20_24	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
		AÑOS (HC 963279)			
URGENTE	**CARDIO 4B**	0200150688 GALEAS LOPEZ ROSA ELVIRA H.C.: 1814762 (HC 1814762)	E: TAC SIMPLE DE ENCEFALO, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y PELVIS PENDIENTE INFORME	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
CONTROL	**CARDIO 4B**	0200150688 GALEAS LOPEZ ROSA ELVIRA H.C.: 1814762 (HC 1814762)	L: CONTROL DIARIO DE ELECTROLITOS	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**EMER_4**	CHIPANTAXI GUAÑA MARIANA (HC 521857)	INTERCONSULTA NEUMOLOGIA PARA TRAMITE DE OXIGENO	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	**EMER_4**	CHIPANTAXI GUAÑA MARIANA (HC 521857)	BAJAR A AVERIGUAR FECHA DE BIOPSIA, YA ENTREGADO EL TRAMITE, AUN NO APROBADO POR RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**EMER_5**	CABEZAS ALMEIDA VICTOR MANUEL (HC 2067347)	PLACA ED PELVIS PENDIENTE REVISAR	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**INFECTO**	CARDENAS CORONEL CESAR WASHINGTON C (HC N/D)	REVALORACION POR NEUMOLOGIA	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
STAT	**INFECTOLOGIA 4D**	GUERRON CASARES VICTOR MISAEL C (HC 165405)	REPETIR ELECTROLITOS STAT + UREA, CREATININA	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	**INFECTOLOGIA 4 C**	ARAUJO FIALLOS FAUSTO RAMIRO (HC N/D)	HEMOCULTIVO X 2 STAT	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**INFECTOLOGIA 4 C**	ARAUJO FIALLOS FAUSTO RAMIRO (HC N/D)	L: HOY 21H00 ELECTROLITOS MAGNESIO	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
CONTROL	**INFECTO 1B**	ANDRANGO SIMBAÑA GONZALO (HC 307712)	CONTROL DIARIO DE ELECTROLITOS	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**INFECTO 1B**	ANDRANGO SIMBAÑA GONZALO (HC 307712)	REVALORACION POR INFECTOLOGÍA	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	**INTERMEDIOS**	GOMEZ ESPINOZA JUSTO ANGEL . (HC N/D)	ELECTROLITOS STAT	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
CONTROL	**INTERMEDIOS**	GOMEZ ESPINOZA JUSTO ANGEL . (HC N/D)	MAÑANA AM: ELECTROLITOS, UREA, CREATININA	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
STAT	**INTERMEDIOS**	GOMEZ ESPINOZA JUSTO ANGEL . (HC N/D)	HEMOCULTIVOS PENDIENTE RESULTADOS, /VERIFICAR SE HAYA ENVIADO MUESTRA	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente

Prioridad	Cama	Paciente	Tarea / Pendiente	Horario / Ventana	Estado
URGENTE	**INTERMEDIOS**	GOMEZ ESPINOZA JUSTO ANGEL . (HC N/D)	REINTERCONSULTAR A TRAUMATOLOGÍA CON RESULTADOS DE RESONANCIA DE CODO	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
URGENTE	**NEUMOLOGIA 10C**	C (HC 625308)	PENDIENTE INFORME DE TC S/C DE TÓRAX ABDOMEN Y PELVIS	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente
CONTROL	**NEUMOLOGÍA 8B**	RODRIGUEZ QUIÑONEZ FRANKLIN (HC 2087745)	CONTROL DIARIO DE ELECTROLITOS, BIOMETRÍA Y TIEMPOS DE COAGULACIÓN	`NOCTURNA_20_24`	☐ Pendiente

Mapa Microbiológico y Aislamientos de Alerta

Cama	Paciente	Muestra	Microorganismo	Patrón / Resistencia	Terapia Sugerida / Sensible
-	-	-	No se registran cultivos activos	-	-

Detalle Clínico por Áreas y Camas

Hospitalización (17 pacientes) Periféricos (12 pacientes)

Emergencia / Observación (24 pacientes)

Cama 10A: MOSQUERA SALVADOR PATRICIA ALEXANDRA C

- **HC:** `1334681` | **Cédula:** 1706511530 | **Edad:** 63 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** LITIASIS RENAL, YA HAN REALIZADO LITOTRICIA; COLELITIASIS DESDE ENERO 2026; OSTEOPOROSIS; PROLAPSO VESICAL DESDE HACE 4 MESES; INFECCION DE VIAS URINARIAS A REPETICIÓN

Diagnósticos Activos:

- SEPSIS A DOBLE FOCO URINARIO E INTESTINAL

- DC INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE
- LESIÓN RENAL AGUDA KDIGO III CKD EPI: 14 ML/MIN
- TROMBOCITOPENIA POR SEPSIS
- HIPONATREMIA HIPOOSMOLAR HIPOVOLEMICA /HIPOKALEMIA. /ACIDEMIA METABÓLICA
- FALLO MULTIORGANICO RENAL, HEPÁTICO, COAGULACIÓN. APACHE 13 PUNTOS

Medicación Activa:

- MEROPENEM 1 GRAMO IV CADA 8 HORAS (7) FI:05/11/2026 CIE: N390
- PARACETAMOL 1 GRAMO IV PRN
- OMEPRAZOL 20MG VO QD
- FUROSEMIDA 40MG IV 08H00 Y 20MG IV 18H00

Pendientes:

- ☐ URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** UROTAC SIMPLE
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** RMN DE COLUMNA LUMBAR
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** ELECTROFORESIS DE PROTEINAS (TRAMITE DERIVACION)
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** PD RESULTADOS DE HEMOCULTIVOS
- ☐ URGENTE **[LABORATORIO]** L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROLITOS CALCIO IONICO (CONTEO MANUAL DE
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** PLAQUETAS,) DIMERO D,PERFIL LIPIDICO,PERFIL HEPATICO, LIPASA
- ☐ STAT **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** EKG STAT
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** GSA PRN
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** ELECTROLITOS (GSA 16H26): K: 3.3 (DESCENSO EN RELACION AL SERICO MATUTINO DE
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** 3.99), NA: 136, CL: 107
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** HEMOCULTIVOS NEGATIVOS

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: - LITIASIS RENAL, YA HAN REALIZADO LITOTRICIA - COLELITIASIS DESDE ENERO 2026 - OSTEOPOROSIS - PROLAPSO VESICAL DESDE HACE 4 MESES - INFECCION DE VIAS URINARIAS A REPETICIÓN

Observaciones / Novedades:

> IC HEMATOLOGIA IC CIRUGIA GENERAL IC NEUMOLOGIA (INICIO DE FTR) IC UROLOGIA

Cama 10B: REYES SANCHEZ INES MAGDALENA C

- **HC:** `8140` | **Cédula:** 1703334647 | **Edad:** 79 AÑOS | **Sexo:** N/R

- **Antecedentes (APP):** HIPERTENSIÓN ARTERIAL; DIABETES MELLITUS 2; HIPOTIROIDISMO; HIPOACUSIA BILATERAL; GONARTROSIS BILATERAL; LINFOMA (GANGLIO LINFATICO NEGATIVO PARA MALIGNIDAD (0/1) FAMILIAR MENCIONA; QUE RECIBIO QUIMIO Y RADIOTERAPIA POR DICHO DIAGNOSTICO

Diagnósticos Activos:

- CHOQUE SÉPTICO DE FOCO PULMONAR SUPEREDARP
- TROMBOSIS VENOSO MI DERECHO
- FLUTTER AURICULAR DE CONDUCCIÓN VARIABLE
- CAHVAS 5 , HAS BLED 3
- PO 250.5, SAFI 233

Medicación Activa:

- ENOXAPARINA 60 MG SC CADA 12 HORAS
- BISOPROLOL 2.5 MG VO QD
- LEVOTIROXINA 50 MCG VIA ORAL LUNES A JUEVES
- LEVOTIROXINA 75 MCG VO VIERNES SABADO Y DOMINGO
- INSULINA CRISTALINA POR ESCAPES:
- 180 - 220 2 UI
- 220 - 260 4 UI
- 260 - 300 6 UI
- > 300 8 UI

- SI GLUCEMIA MENOR A 70, PASAR 200 ML DE DEXTROSA AL 10% Y REPETIR

Pendientes:

- [ ] URGENTE **[LABORATORIO]** E: RMN DE ENCEFALO AGENDAR HOY EN LA MAÑANA
- [ ] STAT **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** EKG CADA DIA (STAT)
- [ ] URGENTE **[LABORATORIO]** L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROITOS CALCIO IONICO MAGNESIO DIMERO D
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** PCR PERFIL HEPATICO
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** GSA PRN
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** LABORATORIOS (17H02): ELEVACION AGUDA DE AZOADOS CON CR 1.99 (PREVIA 0.84) Y
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** UREA 185 (BUN 86). ELECTROLITOS CONSERVADOS (K 4.36, NA 141.9, MG 2.14, CA
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** IONICO 1.32). PERFIL INFECCIOSO EN DESCENSO (LEUCOCITOS 7.17, PCR 21.7). INR
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** 1.74

Observaciones / Novedades:

> IC NEUROLOGIA IC CARDIOLOGIA IC TRABAJO SOCIAL

Cama 10C: CHANGO GADVAY MARIA ADELAIDA

- **HC:** `1996362` | **Cédula:** N/R | **Edad:** 65 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ARTRITIS REUMATOIDE HACE 14 AÑOS; FIBROMIALGIA HACE 10 MESES

Diagnósticos Activos:

- DIAGNOSTICOS ACTIVOS:
- MIELITIS TRANSVERSA AUTOINMUNE / LESION INTRAMEDULAR C1 (EN RESOLUCION
- PARCIAL)
- ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA EN TRATAMIENTO CON INMUNOGLOBULINA
- POLINEUROPATIA AXONAL SENSITIVO-MOTORA / ATROFIA MUSCULAR
- HIPOPOTASEMIA MODERADA CRONICA / PROTEINURIA NO NEFROTICA
- TROMBOEMBOLIA PULMONAR EN ESTUDIO BAJO ANTICOAGULACION
- ULCERA POR PRESION SACRA GRADO I

Medicación Activa:

- IV PASAR EN 4 HORAS
- ENOXAPARINA 80MG SC CADA 12 HORAS
- ESPIRONOLACTONA 50MG VO CADA DIA
- TRAMADOL 50MG + 50ML SS 0.9% IV CADA 12 HORAS
- METOCLOPRAMIDA 10MG IV ANTES DE TRAMADOL
- LACTULOSA 60 ML VO CADA DIA
- QUETIPINA 25MG VO HS (19H00)

Pendientes:

- ☐ URGENTE **[LABORATORIO]** E: LABS: HBS, HBC, HEPATITIS C, VIH, QUANTIFERON PENDIENTE
- ☐ URGENTE **[LABORATORIO]** L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROLITOS DIMERO D MAGNESIO CALCIO IONICO
- ☐ RUTINA **[INTERCONSULTA]** C: ORDENES DE REUMATOLOGIA (DIARIO)
- ☐ URGENTE **[INTERCONSULTA]** IC FISIROTERAPIA MOTORA
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** O: NOVEDADES

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 2026/11/07 PCR CUANTITATIVO ULTRASENSIB..: 45.90 LEUCOCITOS (WBC 6.21 HEMOGLOBINA (HGB 12.2 HEMATOCRITO

(HCT 37.9 PLAQUETAS 523.000 CLORO 105 POTASIO 2.81 SODIO 140.3 NITROGENO UREICO EN SUERO 10 UREA SUERO 21.8 CREATININA 0.36

Observaciones / Novedades:

> LABORATORIOS (13H58): K: 3.46 (EN FRANCA MEJORIA TRAS REPOSICION AM), MG: 1.77, NA: 135.3, CL: 102. FUNCION RENAL CONSERVADA (CR 0.42, UREA 33.4). DIMERO D EN DESCENSO (2.12 VS 6.44 PREVIO). LEUCOCITOS 6.73, HB 11.6

Cama 10D: OÑA TELLO JOSELYN CAROLINA

- **HC:** `1719421` | **Cédula:** N/R | **Edad:** 30 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES; SINDROME DE GARDNER; ARTRITIS REUMATOIDE, POLIARTRITIS CCP POSITIVO (DG A LOS 22 AÑOS); POLIPOMATOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR HACE 14 AÑOS; FISTULA ANAL; OBSTRUCCIÓN INTESTINAL PARCIAL; ANEMIA CRÓNICA; TRASTORNO ELECTROLÍTICO CRÓNICO

Diagnósticos Activos:

- INFECCIÓN O ABSCESO DE PARTES BLANDAS
- INFECCIÓN VÍAS URINARIAS TUMBARELLO 5 PUNTOS EN RESOLUCIÓN
- DOLOR CRÓNICO EXACERBADO
- PROCTORRAGIA OAKLAND DE 20 PUNTOS
- PROLONGACIÓN DE
- TIEMPOS DE COAGULACIÓN **SUSPERADA**
- ENFERMEDAD RENAL AGUDA SUPERADA *** SUPERADA**
- REACCION AL ESTRES GRAVE Y TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN

Medicación Activa:

- CIPROFLOXACINO 500 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS FI: 10/11/2026 D: 02
- AMIKACINA 1 GRAMO VIA ORAL QD STA Y MAÑANA FI: 11/11/2026 D: 02/2
- FLUCONAZOL 400 MG IV CADA DIA FI: 11/11/2026 D: 02/7
- OMEPRAZOL 40 MG IV CADA DIA
- PARACETAMOL 1 GR IV CADA 8 HORAS
- FITOMENADIONA 10 MG IV CADA DIA
- MORFINA 35 MG + 96 CC DE SOLUCION SALINA 0.9% INTRAVENOSO, PASAR A 4CC/HORA
- MORFINA 3.5 MG INTRAVENOSO EN ESTE MOMENTO Y CASO DE DOLOR SEVERO, MAXIMO 3
- RESCATES, REGISTRAR EN SISTEMA PARA AJUSTE DE DOSIS BASAL
- ONDANSETRON 8 MG INTRAVENOSO EN ESTE MOMENTO Y CADA 12 HORAS

Pendientes:

- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** PENDIENTE INFORME ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS DE CABEZ Y TORAX POSTERIOR
- [ ] URGENTE **[LABORATORIO]** PENDIENTE TOMOGRAFIA SIMPLE DE CABEZA, TORAX Y PELVIS
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** L: LABORATORIO CENTRAL 13/11/2026: BIOMETRIA, PCR, ELECTROLITOS,
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** UREA,CREATININA
- [ ] URGENTE **[INTERCONSULTA]** VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO POR EL COMITÉ DE BIOÉTICA

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: UROCULTIVO: MICROORGANISMO: Proteus mirabilis AMIKACINA SENSIBLE / 4 ug/mL CEFTRIAXONA SENSIBLE / <= 0,25 ug/mL Cefazolina (O) SENSIBLE / <= 4 ug/mL GENTAMICINA RESISTENTE / 8 ug/mL TRIMETOPRIMA/SULFA RESISTENTE / >= 320 ug/mL CIPROFLOXACINO RESISTENTE / >= 4 ug/mL Resultado: Positivo; Contaje de Colonias: > 100.000 UFC/ml;

Observaciones / Novedades:

> C: INDICACIONES DE CLINICA DEL DOLOR INDICACIONES DE COLOPROCTOLOGIA INDICACIONES DE PSIQUIATRIA INDICACIONES DE PSICOLOGIA ORDENES DE CIRUGIA PLASTICA O. VALORACION Y SEGUIMIENTO POR EL COMITE DE BIOETICA

Cama 11A: YELA DÍAS NELSON ARNULFO

- **HC:** `641333` | **Cédula:** 1705250726 | **Edad:** N/D | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES:; ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5 SECUNDARIA A NEFROPATÍA DIABÉTICA EN HEMODIÁLISIS TRISEMANAL (MARTES, JUEVES Y SÁBADO) NO OLIGÚRICO; INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS NOSOCOMIAL POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE KPC/ENTEROCOCCUS FAECALIS SUPERADA; DIABETES MELLITUS TIPO 2; DISLIPIDEMIA; HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA; TAQUIARRITMIA CARDÍACA TIPO FIBRILACIÓN AURICULAR; HIPERPLASIA E HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA

Diagnósticos Activos:

- DIAGNÓSTICOS ACTIVOS:
- NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN RESOLUCIÓN (CIE-10: J18.9)
- ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5 EN HEMODIÁLISIS (CKD-EPI: 13.14 ML/MIN) (CIE-10: N18.5)
- DIABETES MELLITUS TIPO 2 (CIE-10: E11.9)
- HIPERTENSIÓN ARTERIAL (CIE-10: I10)

Medicación Activa:

- A PASAR 40ML/HORA
- CEFTRIAXOONE 2 GRAMOS IV CADA DIA (1/3) FI: 12/11/2026 A419
- HEPARINA SODICA 5000UI SC CADA 12 HORAS
- LOSARTAN 100 MG VO CADA DIA
- AMLODIPINA 10 MG VO CADA DIA
- CARVEDILOL 6.25 MG VO CADA DIA
- INSULINA NPH 32 UI SC AM
- INSULINA NPH 14 UI SC PM
- 180-230 2UI
- 231-280 3UI

Pendientes:

- ☐ URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** E: PD INFORME DE TAC DE TORAX
- ☐ STAT **[LABORATORIO]** GSA STAT
- ☐ URGENTE **[LABORATORIO]** L: HOY BH UREA CREATININA ELECTROLITOS PCR PERFIL LIPIDICO HBA1C TSH
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** CALCIO IONICO
- ☐ URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** LABORATORIOS (17H00): DESTACA MEJORIA DE AZOADOS POST-DIÁLISIS (UREA 67.8, CR
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** 3.90). SODIO EN 134.0. PERSISTEN LEUCOCITOSIS (14.03) Y ANEMIA (HB 9.0)

Observaciones / Novedades:

> C: IC CENTRO DE HEMODIALISIS IC NEUMOLOGIA (INICIO DE FTR)

Cama 11B: PACHACAMA SUNTAXI FREDDY RODRIGO C

- **HC:** `20` | **Cédula:** 1713637401 | **Edad:** N/D | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO DIAGNOSTICO EN EL 2022; ANEMIA MODERADA MICROCITICA HIPOCROMICA; TROMBOEMBOLIA PULMONAR, ANGIO TOMOGRAFIA TORAX 12/09/2026; SEPSIS POR BACTERIEMIA POR SALMONELLA SUPERADO 10/2026; NEFRITIS LUPICA (POR CLINICA PROBABLE CLASE IV, SLEDAI 2K: 24 ACTIVIDAD; SEVERA); PROTEINURIA SUB NEFROTICA

Diagnósticos Activos:

- LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SLEDAI 2K 10 PUNTOS ACTIVIDAD ALTA
- NEFRITIS LÚPICA
- DERRAME PLEURAL LOCULADO
- ANEMIA MODERADA MICROCÍTICA HIPOCRÓMICA

Medicación Activa:

- CEFTRIAXONA A 2 G IV QD FI: 16/10/2026 D: 27 CIE 10 B99
- PARACETAMOL 1 GR IV CADA 8 HORAS
- MORFINA 4 MG IV EN LA TARDE, DESPUES DE ALMUERZO
- ENOXAPARINA 60 MG SC CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 40 MG INTRAVENOSO CADA DIA
- CARBONATO DE CALCIO SOLIDO ORAL 500 MG VO QD 11 AM
- COTRIMOXAZOL SOLIDO ORAL 800/160 MG LOS DIAS MARTES JUEVES SABADO A LAS 2
- GABAPENTINA SOLIDO ORAL 300 MG VO QD A LAS 9 PM
- TRAMADOL 100 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS
- METOCLOPRAMIDA 10 MG INTRAVENOSO CADA 8 HORAS

Pendientes:

- ☐ RUTINA **[INTERCONSULTA]** INDICACIONES DE REUMATOLOGÍA
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** L: BIOMETRIA, ELECTROLITOS, FUNCION RENAL 12/11/2026
- ☐ RUTINA **[INTERCONSULTA]** BRONCOSCOPIA:10-11-2026
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** INFILTRACION GRADO II DE CARINA SECUNDARIA ENTRE LOBULO SUPERIOR E INFERIOR
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** IZQUIERDO
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** TRAQUEOBRONQUITIS LEVE NO PURULENTA

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: CULTIVO DE LIQ. PLEURAL: MICROORGANISMO: SALMONELLA ENTERICA SSP ENTÉRICA . SENSIBLE A CEFTRIAXONA . LABORATORIOS RECIENTES: HB EN DESCENSO (10.7 G/DL), LEUCOCITOS NORMALES (8.67), FUNCION RENAL CONSERVADA (CR 0.58), ELECTROLITOS EN RANGO (K 3.5). PCR EN DESCENSO CLARO (17.00 PREVIA).

Observaciones / Novedades:

> INMUNOLÓGICOS LABORATORIO ZURITA Y ZURITA 23-09-2026 ANTICUERPOS ANTI-PEPTIDO CITRULINADO (ANTICCP): INFERIOR A 0,50 U/ML-NEGATIVO ANTICUERPOS ANTI-SM (SMITH): INFERIOR A 3,3 CU - NEGATIVO ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINA IGM: 2,10 CU - NEGATIVO ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINA IGG: 9,50 CU - NEGATIVO ANTICUERPOS ANTI-BETA2 GLICOPROTEINA 1 IGM: INFERIOR A 1,1 CU - NEGATIVO

Cama 12A: CALDERON ALMEIDA SIMON BOLIVAR

- **HC:** `2007245` | **Cédula:** 0601406994 | **Edad:** 68 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PERSONALES:; ARRITMIA CARDIACA; PORTADOR DE MARCAPASO; ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO; ANTECEDENTES;

APENDICECTOMIA; COLECISTECTOMIA

Diagnósticos Activos:

- DIAGNÓSTICOS
- 1.- ENDOCARDITIS ASOCIADA A CATETER
- 2.- ARRITMIA CARDIACA/MARCAPASO DC ENDOCARDITIS ASOCIADA A DISPOSITIVO
- PASIVOS
- 1.- HERPES LABIAL
- NO ALERGIAS

Medicación Activa:

- CEFTRIAXONE 2 G IV QD CIE 10:I 339 FI:11-XI-2026 0/28
- VANCOMICINA 1 G IV C/12H CIE 10:I 339 FI:12-XI-2026 1/28
- PARACETAMOL 1 G IV PRN HASTA C/8H (FIEBRE O DOLOR)
- RIBAROXABAN 20 MG P.O. QD 08H00

Pendientes:

- ☐ URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** E: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO JUEVES 12H00
- ☐ URGENTE **[LABORATORIO]** L: PENDIENTE LAB CENTRAL
- ☐ RUTINA **[INTERCONSULTA]** ALTA POR MEDICINA INTERNA Y PASA A CARDIOLOGIA
- ☐ URGENTE **[INTERCONSULTA]** SE REALIZA IC A ODONTOLOGIA PENDIENTE VALORACION

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 2026/11/12 Leucocitos (WBC): 5.48 Hemoglobina (HGB): 15.3 Hematocrito (HCT): 47.0 Volumen corp. medio (MCV): 92.40 Conc. media hemog. (MCH): 30.0 Conc. corp. media (MCHC) de hemo: 32.6 Volumen Medio Plaquetario (MPV): 10.7 Monocitos: 0.48 Eosinófilos: 0.08 Linfocitos: 1.53 Neutrofilos: 3.32 Basófilos: 0.030 Plaquetas: 197.000 Recuento de globulos r

Observaciones / Novedades:

> O: REVALORACION POR CARDIOLOGIA IC ODONTOLOGIA

Cama 13B: CANTOS AGUIRRE GUADALUPE ESPERANZA C

- **HC:** `140019` | **Cédula:** 1703701944 | **Edad:** 73 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES; HIPERTENSION ESENCIAL DX A LOS 40 AÑOS; INFECCION DE VIAS URINAS RECURRENTES; TRASTONO DE ANSIEDAD- INSOMNIO

Diagnósticos Activos:

- DIAGNÓSTICOS ACTIVOS:
- CRISIS CONVULSIVA EN ESTUDIO
- INFECCION DE VIAS URINARIAS K. PNEUMONIAE SENSIBLE
- HIPONATREMIA SUPERADA
- HIPOKALEMIA MODERADA

Medicación Activa:

- CEFTRIAXONA 2 GR INTRAVENOSO CADA DIA D5/7 FI 09/11/2026, CIE-10:
- PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO POR RAZONES NECESARIAS
- OMEPRAZOL 20 MG VIA ORAL CADA DIA
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA
- ACIDO VALPROICO 500 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS
- LOSARTAN 100 MG VIA ORAL CADA DIA AM
- AMLODIPINO 10 MG VIA ORAL CADA DIA PM
- CARVEDILOL 12.5 MG VIA ORAL CADA 12 HORAS
- GABAPENTINA 300 MG VIA ORAL CADA DIA 18:00
- MIDAZOLAM 2.5 MG INTRAVENOSO PREVIO A SEDACION

Pendientes:

- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** E: RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE Y CONTRASTADA DE ENCEFALO EL DIA DOMINGO CON SEDACION
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** ELECTROENCEFALOGRAMA
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** L: NO

Observaciones / Novedades:

> INDICACIONES DE NEUROLOGIA

Cama 6A: RODRIGUEZ MORENO SEGUNDO EZEQUIEL

- **HC:** `2013397` | **Cédula:** 1709777906 | **Edad:** 59 AÑO | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** HIPOTIROIDISMO; HIPERTENSIÓN ARTERIAL; NEUMONIA ASOCIADA A LA COMUNIDAD FINALES DE OCTUBRE/2026, ENVIADO CON ANTIBIOTICOTERAPIA VIA ORAL + INHALADORES; HIPERTENSIÓN ARTERIAL; ARTRITIS REUMATOIDE EN SEGUIMIENTO POR REUMATOLOGÍA IESS DISPENSARIO; EN REVALORACIÓN AL MOMENTO; NEUMONIA HACE DOS AÑOS

Diagnósticos Activos:

- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. CIE 10: J159 SUPERADA
- CHOQUE SÉPTICO DE FOCO PULMONAR SUPERADO CIE 10: R572
- LESIÓN RENAL AGUDA KDIGO C3 CIE-10: N179 SUPERADO

Medicación Activa:

- PARACETAMOL 1 GRAMO VIA ORAL CADA 8 HORAS
- OMEPRAZOL 40 MILIGRAMOS INTRAVENOSO CADA DIA
- ENOXAPARINA 60 MG APLICAR SUBCUTANEO, CADA DIA
- LEVOTIROXINA 50 MICROGRAMO VIA ORAL CADA DIA 06:00
- TRAMADOL 50 MILIGRAMOS INTRAVENOSO POR RAZONES NECESARIAS
- METOCLOPRAMIDA 10 MILIGRAMOS INTRAVENOSO POR RAZONES NECESARIAS
- HIDROCORTISONA 150 MG IV QD 8 AM
- TRI-K 10 ML DILUIR EN MEDIO VASO DE JUGO DE NARANJA VO CADA 8 HORAS (D3/3)
- ENALAPRIL 10 MILIGRAMO VIA ORAL CADA DIA
- PREDNISONA 20 MILIGRAMO CADA DIA ***SUSPENDE HACE 3 DIAS***

Pendientes:

- [ ] URGENTE **[LABORATORIO]** PENDIENTE EXÁMENES GENERADOS EL 12/11/2026
- [ ] RUTINA **[INTERCONSULTA]** INDICACIONES DE REUMATOLOGÍA
- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** PENDIENTE TAC SIMPLE DE TÓRAX
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** C: COMUNICAR
- [ ] URGENTE **[INTERCONSULTA]** VALORACIÓN POR NEUMOLOGÍA
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** INICIO DE OXIGENO DOMICILIARIO
- [ ] RUTINA **[INTERCONSULTA]** REUMATOLOGÍA
- [ ] RUTINA **[INTERCONSULTA]** INDICACIONES DE DERMATOLOGÍA
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** UREA 10% SEMISOLIDO CUTANEO APLICAR TOPICO BID POR 15 DIAS EN MANOS
- [ ] CONTROL **[LABORATORIO]** PROXIMO CONTROL: 06/11/2026

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 10/11/2026 ACIDO LACTICO.: 1.0 BE.: 5.5 Ca: 1.1 Cl: 100.0 COHb: 1.9 Glu: 130.0 HCO3: 28.8 Hct: 33.7 K.: 3.9 MetHb.: 0.2 Na.: 137.0 O2Hb: 61.8 O2SAT.: 63.1 PCO2.: 37.6 PHS: 7.493 PO2: 32.6 TCO2.: 30.0 Leucocitos (WBC)..: 4.98 Hemoglobina (HGB): 10.6 Hematocrito (HCT).: 33.0 Volumen corp. medio (MCV).: 85.40 Conc.media hemog.(MCH).....: 27.4 Con

Observaciones / Novedades:

> LABORATORIOS SOLICITADOS POR REUMATOLOGIA: FACTOR REUMATOIDEO.....: 13.1 C3.....: 0.85 C4.....: 0.07 ANTICOAGULANTE LUPICO.....: 1.08 EXAMENES DE LABORATORIO POR SERVICIO BASE: FACTOR REUMATOIDE, ANTICOAGULANTE

Cama 6C: ALMEIDA JARAMILLO JUAN CARLOS C

- **HC:** `2086486` | **Cédula:** 1705956132 | **Edad:** 65 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES:; HIPERTENSIÓN ARTERIAL DIAGNOSTICADA EN EL 2004; DIABETES MELLITUS DIAGNOSTICADA EN EL 2014; CEFALEA DESDE EL 2020; DOLOR EN MIEMBRO SUPERIOR DERECHO DESDE HACE 3 MESES

Diagnósticos Activos:

- ADENOPATÍAS GENERALIZADAS (CERVICALES, AXILARES, INGUINALES)
- HIPERTENSIÓN ARTERIAL
- DIABETES MELLITUS
- SINDROME CONSTITUCIONAL

Medicación Activa:

- AMLODIPINO 5 MG VO QD PM
- METFORMINA 850 MG VO TID * SUSPENDER *
- AMITRIPTILINA 25 MG VO QD PM
- TRAMADOL 10 GOTAS VO BID
- PARACETAMOL 1 GR VIA ORAL CADA 8 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA
- INSULINA NPH 12 UI SC AM Y 6 I SC PM
- 180 - 230 MG/DL: 2 UI SUBCUTANEO
- 231 - 280 MG/DL: 4 UI SUBCUTANEO
- 281 - 330 MG/DL: 6 UI SUBCUTANEO

Pendientes:

- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** E: EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS:
- ☐ URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** TAC SIMPLE DE CRÁNEO PENDIENTE
- ☐ URGENTE **[LABORATORIO]** PENDIENTE REALIZACIÓN
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** RMN SIMPLE DE COLUMNA CERVICAL MADRUGADA DEL 13 DE NOVIEMBRE
- ☐ URGENTE **[LABORATORIO]** PAAF DE GANGLIO CERVICAL (IMAGEN) PENDIENTE REALIZACIÓN
- ☐ RUTINA **[INTERCONSULTA]** INDICACIONES DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** 2026/11/11 12:04 ENDOSCOPIA
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** DIAGNOSTICO
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** LESION DE ASPECTO PAPILOMATOSO EN ESOFAGO MEDIO RESECADO
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** GASTROPATIA ERITEMATOSA LEVE DE ANTRO
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** CICATRIZ LINEAL DE ULCERA PREVIA EN CUERPO SAKITA MIWA H2
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** ESTUDIO NEGATIVO PARA LESIONES NEOPLASICAS

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 2026/11/09 TSH.: 1.30 INR.: 1.14 TIEMPO DE PROTROMBINA (TP).: 12.4 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTP)..: 28.3 Leucocitos (WBC).: 5.67 Hemoglobina (HGB).: 16.0 Hematocrito (HCT).: 47.9 Eosinófilos %.: 2.7 Linfocitos %.: 36.6 Neutrofilos %.: 54.1 COLESTEROL HDL: 32.10 COLESTEROL LDL: 104.70 GLUCOSA.: 98 CLORO: 106 POTASIO: 3.84 SODIO: 138.2 CALCIO IONICO

Cama 6D: FARINANGO ANDRADE JUAN MANUEL

- **HC:** `N/D` | **Cédula:** N/R | **Edad:** 88 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** HIPOTIROIDISMO; DIABETES TIPO 2; HIPERPLASIA PROSTÁTICA; COLECISTECTOMIA; CATARATA BILATERAL; LIPOMA EN BRAZO DERECHO

Diagnósticos Activos:

- DERRAME PLEURAL GRADO 2
- SINDROME CONSTITUCIONAL
- COLECCIÓN SUBFRÉNICA EN ESTUDIO

Medicación Activa:

- PARACETAMOL 1 GR IV CADA 8 HORAS
- METOCLOPRAMIDA 10 MG IV PRN
- FUROSEMIDA 40 MG IV 08H00 AM Y 20 MG IV 14H00
- CEFTRIAXONA 1 GR IV CADA 12 HORAS (D:2) FI:10/11/2026 CIE10: A065
- METRONIDAZOL 500 MG IV CADA 8 HORAS (D:2) FI:10/11/2026 CIE10: A065
- LOSARTAN 50 MG VO QD
- LEVOTIROXINA 75 MCG VO QD
- TAMSULOSINA 0,4 MG VO QD
- METFORMINA 500 MG VO QD *******SUSPENDIDO.******

Pendientes:

- ☐ URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** E:PENDIENTE RX DE TÓRAX ANTEROPOSTERIOR Y LATERAL
- ☐ RUTINA **[LABORATORIO]** CIRUGIA PULMONAR ALTA

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 2026/11/12 PCR CUANTITATIVO ULTRASENSIBLE: 75.80 PROCALCITONINA LAB. CLINICO: 0.19 INR: 1.23 TIEMPO DE PROTROMBINA (TP): 13.3 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTP): 25.5 LEUCOCITOS (WBC): 4.65 HEMOGLOBINA (HGB): 13.7 HEMATOCRITO (HCT): 44.2 VOLUMEN CORP. MEDIO

(MCV): 85.60 CONC. MEDIA HEMOG. (MCH): 26.6 LINFOCITOS: 0.78 NEUTROFILOS: 3.33 BASOFILOS: 0.040

Cama 7: VINUEZA ROJAS ARTURO MIGUEL 77 AÑOS 239902

- **HC:** `N/D` | **Cédula:** N/R | **Edad:** 77 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PERSONALES:; HIPERTENSION ARTERIAL DIAGNOSTICADO HACE 30 AÑOS; DISLIPIDEMIA; ENFERMEDAD RENAL CRONICA; ANTECEDENTES QUIRURGICOS:; APENDICECTOMIA; RECONSTRUCCION NASAL; CRANEOTOMIA FRONTO TEMPORO PARIETAL IZQUIERDA MAS EVACUACION DE

Diagnósticos Activos:

- TRAQUEITIS
- HIPERTENSIÓN ARTERIAL
- DISLIPIDEMIA
- ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 3B (TFG POR CKD-EPI: 31,84)
- PORTADOR DE TRAQUEOSTOMO
- HEMATOMA SUBDURAL AGUDO HEMISFERICO IZQUIERDO PARIETAL DERECHO EVACUADO
- NECROSIS DE COLGAJO EN CUERO CABELLUDO RESUELTO PARIETAL POSTERIOR IZQUIERDO +
- INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA FRONTO TEMPORO PARIETAL IZQUIERDA + EMPIEMA

Medicación Activa:

- LEVETIRACETAM 500 MILIGRAMOS POR GASTROSTOMIA CADA 12 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC QD
- BUSCAPINA 1 TABLETA POR GASTROSTOMIA C/8H
- EMPAGLIFLOZINA 10 MILIGRAMOS POR SONDA OROGASTRICA CADA DIA
- SIMVASTATINA 40 MILIGRAMOS POR SONDA OROGASTRICA CADA DIA
- NEBULIZACIONES CON BROMURO DE IPRATROPIO 2 ML + SOLUCION SALINA 0.9% 5 ML
- CADA 6 HORAS
- LAGRIMAS ARTIFICIALES UNA GOTA CADA 2 HORAS AMBOS OJOS SIEMPRE

Observaciones / Novedades:

> O: FTR RESPIRATORIA Y REHABILITACIÓN CURACIONES AVANZADAS POR CLÍNICA DE HERIDAS

Cama 8: NICOLALDE CENTENO CESAR ENRIQUE

- **HC:** `554153` | **Cédula:** 1715905293 | **Edad:** 40 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** SINDROME . DE DOWN; HIPOTIROIDISMO; POLIGLOBULIA; DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL 70%

Diagnósticos Activos:

- HEPATOPATÍA EN ESTUDIO EN ESTUDIO DE POSIBLE HEPATITIS TÓXICA VS MEDICAMENTOSAS
- NEUTEOFEMIA CON ANTIBIOTICO TERAPI EMPÍRICA
- BICITOPENIA EN ESTUDIO
- TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO LEVE
- HIPOGLICEMIA REFRACTARIA SUPERADA
- DC. PARANEOPLÁSICO
- INFECCION DE VIAS URINARIAS
- SINDROME HEPÁTICO MIXTO COLESTÁSICO Y CITOLITICO

Medicación Activa:

- CEFEPIME 2 GRAMOS IV CADA 8 HORAS (2/3) FI:10/11/2026
- ACICLOVIR 400MG VO CADA 12 HORAS (1/5)
- FLUCONAZOL 400MG VO CADA DIA (1/5)
- LEVOTIROXINA 75MCG VO CADA DIA
- TRAMADOL 50MG + 50ML SS 0.9% IV PASAR PRN
- RISPERIDONA 8 GOTAS VO PRN (AGITACION PSICOMOTRIZ)
- QUETIAPINA 25 MG VO HS , ADICIONAR 25 MG VO HS PRN

Pendientes:

- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** PD RESULTADOS DE BIOPSIA
- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** PD REALIZACION ECO DOPPLER PORTAL
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** 11.11.2026
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** MEDULOGRAMA: DILUIDO, NO VALORABLE
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** IMPRONTA: DILUIDO NO VALORABLE
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** 10.11.2026 FROTIS DE SANGRE PERIFERICA
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** FORMULA DIFERENCIAL MANUAL
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** SEGMENTADOS: 68 %
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** LINFOCITOS: 16 %
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** MONOCITOS:16 %
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** HIPOSEGMENTADOS +++

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 22026/11/12 PCR CUANTITATIVO ULTRASENSIBLE: 78.40 Leucocitos (WBC): 2.11 Hemoglobina (HGB): 11.8 Hematocrito (HCT):

35.4 Volumen corp. medio (MCV): 95.60 Conc. media hemog. (MCH): 31.8 Neutrofilos: 1.68 Basófilos: 0.000 Plaquetas: 55.000 CLORO: 100 POTASIO: 3.46 SODIO: 136.7 NITROGENO UREICO EN SUERO: 17 UREA SUERO: 37.1 CREATININA: 0.44

Observaciones / Novedades:

> L: PD RESULTADOS DE LAB CENTRAL C: ORDENES DE HEMATOLOGIA ORDENES DE PSIQUIATRIA O: NOVEDADES

Cama 9A: ROSAS CORREA MARIA ESTHER C

- **HC:** `124595` | **Cédula:** 0600433312 | **Edad:** N/D | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** 2010 CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CRÓNICA SE DESCONOCE EVENTO AGUDO APARENTE IMPLANTE; DE 2 STENTS EN ARTERIA DESCONOCIDA (CLÍNICA PICHINCHA); HIPOTIROIDISMO; HEMORRAGIA VÍTREA; ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS; IMPLANTE DE 2 STENTS POR CARDIOPATÍA EN ARTERIA DESCONOCIDA; HISTERECTOMÍA; COLECISTECTOMÍA

Diagnósticos Activos:

- CA DE OVARIO CON ÍNDICE DE ROMA DE 97.9 (ALTO RIESGO PARA CÁNCER OVÁRICO EPITELIAL)
- PERITONITIS BACTERIANA SUPERADA
- DERRAME PLEURAL DERECHO. SUPERADO
- HIPOACUSIA BILATERAL

Medicación Activa:

- OMEPRAZOL 20 MG VIA ORAL CADA DIA AM
- ESPIRONOLACTONA 25 MG VO CADA DIA
- PARACETAMOL 1 GR VIA ORAL CADA 8 HORAS
- TRAMADOL 100 MG IV CADA 12 HORAS
- METOCLOPRAMIDA 10 MG VO CADA 8 HORAS - 20 MIN ANTES DE CADA COMIDA
- MAGALDRATO CON SIMETICONA 10 CC POSTERIOR A CADA COMIDA
- ENOXAPARINA 60 MG SC QD
- CAPSULAS DE SAL 1 GR MG VIA ORAL CADA DIA
- KETOROLACO 30 MG IV CADA 8 HORAS
- OMEPRAZOL 40 MG IV CADA DIA HORA SUEÑO

Pendientes:

- [ ] STAT **[LABORATORIO]** RADIOGRAFIA DE TORAX YA
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** HISOPADO RECTAL PARA BACTERIA RESISTENTES TOMADO
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** DESTET DE OXIGENO

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 2026/11/01 HORA: CULTIVO DE LIQUIDO ASCÍTICO…..: A/B RESULTADOS: MICROORGANISMO: PSEUDOMONAS AERUGINOSA RESULTADO: POSITIVO; MICROORGANISMO RESISTENTE A CARBAPEN MICOS. NEGATIVO PARA PRODUCCI N E NZIM TICA DE CARBAPENEMASAS, RESISTENCIA MEDIADA POR IMPERMEABILIDAD; . 2026/11/12 ACIDO LACTICO: 2.2 GLU: 155.0 HCO3: 23.0 K: 4.1 NA: 131.0 O2HB: 87.4

Observaciones / Novedades:

> CITOLOGÍA DE BLOQUE CELULAR E INMUNOHISTOQUÍMICO EN BUSCA DE PRIMARIO (PENDIENTE RESULTADO)

Cama 9B: CARRERA AGUIRRE MARTHA GRACIELA C

- **HC:** `2045964` | **Cédula:** 1702915719 | **Edad:** 88 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** DEMENCIA NO ESPECIFICADA DIAGNOSTICADA POR GERIATRIA; HIPERTENSIÓN ARTERIAL; PÉNFIGO VULGAR; INFECCION DE VIAS URINARIAS (HOSPITALIZADA SEPTIEMBRE 2025); TRASTORNO BIPOLAR DIAGNOSTICADO 2023

Diagnósticos Activos:

- TRASTORNO DEGLUTORIO EN CONTEXTO DE DEMENCIA TIPO ALZHEIMER
- ANEMIA MODERADA MACROCÍTICA
- ZONA DE PRESIÓN EN SACRO ANTERIOR EN CICATRIZACIÓN
- NEUMONIA POR ASPIRACION SUPERADA
- HIPERNATREMIA SEVERA HIPOVOLEMICA AGUDA SINTOMATICA SUPERADA
- LESIÓN RENAL AGUDA KDIGO C2 SUPERADA

Medicación Activa:

- I. DEXTROSA 5% EN SOLUCION SALINA 1000 CC PASAR IV A 40 CC/H
- PARACETAMOL 1 G IV PRN
- ENOXAPARINA 40 MG SC QD
- FUROSEMIDA 40 MG INTRAVENOSO CADA DIA
- ESPIRONOLACTONA 25 MG POR SONDA NASOGASTRICA
- ***SUSPENDER*** AMPICILINA + SULBACTAM 3 G IV CADA 6 HORAS FI: 29/10/2026 CIE
- INDICACIONES DE PSIQUIATRIA 04/11/2026
- ACIDO VALPROICO 250MG TABLETA VO BID POR 10 DIAS
- RISPERIDONA GOTAS: 5 GOTAS TID POR 10 DIAS
- LOSARTAN 100 MILIGRAMOS VIA ORAL DIFERIDO**********

Pendientes:

- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** E. NO AMERITA
- [ ] URGENTE **[LABORATORIO]** L. PENDIENTE RESULTADOS DE ELECTROLITOS 12/11/2026
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** C. INDICACIONES DE GASTROENTEROLOGIA: GASTROSTOMIA 12/11/2026 16:00

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 2026/11/13 CLORO….: 95 POTASIO…: 3.73 SODIO..: 129.2 CALCIO IONICO EN SUERO..: 1.16 CALCIO IONICO EN SUERO..: 1.16 CALCIO TOTAL: 7.3 FOSFORO..: 3.5 MAGNESIO: 1.63 . 2026/11/11 CLORO….: 93 POTASIO…: 4.68 SODIO: 127.8

Observaciones / Novedades:

> GASTROSTOMÍA A LAS 16: 00 12/11/2026 INDICACIONES DE GASTROENTEROLOGIA POST PROCEDIMIENTO

Cama 9C: MORENO BARRIGA BLANCA ALICIA

- **HC:** `1734898` | **Cédula:** 0500728902 | **Edad:** 72 AÑOS | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO DE MÚLTIPLES TERRITORIOS Y BILATERALES; INSUFICIENCIA CARDIACA FEVI PRESERVADA 60% PERFIL HEMODINÁMICO A, ETIOLOGIA VALVULAR POR ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA, ESTADIO C, NYHA II; SINDROME NEFRÓTICO EN ESTUDIO; INJURIA MIOCÁRDICA AGUDA SECUNDARIA A SINDROME CEREBRO CORAZON, TIPO II; DISLIPIDEMIA DIAGNOSTICADA HACE APROXIMADAMENTE 2 MESES, SIN TRATAMIENTO

Diagnósticos Activos:

- SINDROME NEFRÓTICO
- INSUFICIENCIA CARDIACA FEVI PRESERVADA 60% PERFIL HEMODINÁMICO A, ETIOLOGIA VALVULAR POR ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA, ESTADIO C, NYHA II DESCOMPENSADA
- HIPOKALEMIA LEVE EN REPOSICIÓN
- BACTERIURIA ASINTOMATICA
- ENCEFALOMALACIA

Medicación Activa:

- OMPERAZOL 20 MG P.O QD
- UROCIT 2 CAPSULAS VIA ORAL CADA 8 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SUBCUTANEO CADA 12 HORAS
- PARACETAMOL 1 GRAMO INTRAVENOSO POR RAZONES NECESARIAS
- ATORVASTATINA 40 MG VO QD (ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR

- BETAHISTINA 48 MG VO QD
- EMPAGLIFLOZINA 25 MG VIA ORAL CADA DIA
- ENALAPRIL 5 MG VO QD
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 12 HORAS
- POLIETILENGLICOL 1 CUCHARADA VIA ORAL CADA 12 HORAS

Pendientes:

- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** PD RESULTADO RESULTADO DE ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** SE PROGRAMA CURETAJE PERIODONTAL DE PIEZA DENTAL 36 PARA EL DIA JUEVES 12
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** DE NOVIEMBRE DE 2026 A LAS 16H00
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** ODONTOLOGIA REALIZA PROCEDIMIENTO
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** INDICACIONES DE NEFROLOGIA

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: CLORO: 114 POTASIO: 3.47 SODIO: 143.3 CALCIO IÓNICO EN SUERO: 1.19 CALCIO TOTAL: 7.4 FÓSFORO: 3.1 MAGNESIO: 1.96

Observaciones / Novedades:

> EKG CADA DIA PD INFORME DE BODY TAC SIMPLE Y CONTRASTADA ECO RENAL PD REALIZAR

Cama 9D: GUERRERO PAULA DOLORES NARCIZA

- **HC:** `677814` | **Cédula:** N/R | **Edad:** 63 años | **Sexo:** N/R
- **Antecedentes (APP):** ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONAES; EPILEPSIA. SECUNDARIA A TRAUMATISMO HACE 17 AÑOS; HIPOTIROIDISMO; DISLIPIDEMIA; LESIONES VASCULARES CEREBRALES EN IMAGEN; HIPONATREMIA CRONICA; TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DE MIEMBRO INFERIOR DERECHA; RESIDENTE EN CENTRO DE CUIDADO, DEPENDIENTE DE TERCERAS PERSONAS

Diagnósticos Activos:

- DIAGNOSTICO:
- ANEMIA MACROCITICA SEVERA AGUDA (CAIDA DE HB A 8.1 G/DL - EN SOPORTE
- TRANSFUSIONAL)
- SEPSIS DE FOCO PULMONAR / NEUMONIA ASPIRATIVA (DIA 4 DE TRATAMIENTO)
- DESCARTE DE MENINGOENCEFALITIS VS. ENCEFALOPATIA TOXICO-METABOLICA
- EPILEPSIA SECUNDARIA A TRAUMA / DEMENCIA VASCULAR
- CONSTIPACION

- HIPERNATREMIA MODERADA Y TROMBOCITOPENIA (RESUELTAS)

Medicación Activa:

- IV PASAR 60ML/HORA
- PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GRAMOS IV CADA 6 HORAS (4/5) FI:09/11/2026 A419
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA
- PARACETAMOL 1 GRAMO IV PRN
- BROMURO DE IPATROPIO 2 PUFF CADA 8 HORAS
- ATORVASTATINA 40 MG VO CADA DIA
- ACIDO VALPROICO 1000MG VO CADA 12 HORAS
- LEVOTIROXINA 125 MG VO CADA DIA
- FUROSEMIDA 40MG IV DESPUES DE PAQUETE GLOBULAR

Pendientes:

- [ ] URGENTE **[IMAGEN_PROCEDIMIENTO]** PD RESULTADOS DE TAC DE TORAX
- [ ] RUTINA **[LABORATORIO]** PD RESULTADOS HEMOCULTIVO

Últimos Laboratorios:

- *2026-11-13 (Laboratorios / Gasometría):* resumen: 2026/11/12 HORA: 08:39 LEUCOCITOS (WBC): 5.72 HEMOGLOBINA (HGB): 8.1 HEMATOCRITO (HCT): 25.0 VOLUMEN CORP. MEDIO (MCV): 100.60 CONC. MEDIA HEMOG. (MCH): 32.4 CONC. CORP. MEDIA (MCHC) DE HEMO: 32.4 VOLUMEN MEDIO PLAQUETARIO (MPV): 11.5 MONOCITOS: 0.45 EOSINOFILOS: 0.05 LINFOCITOS: 2.65 NEUTROFILOS: 2.51 BASOFILOS: 0.030 PLAQUETAS: 117.000 RECUENTO D

Observaciones / Novedades:

> MAÑNA 05H00 BH UREA CREATININA ELECTROLITOS